

Fecha Última Actualización: 10-03-2022 15:49:46

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Gloria Irene Aguilera Ubillo
Edad : 56a 3m 2d
Dirección : Apostol Felipe 3016 Pque Sn Fco

Rut : 13.977.055-2
Fecha Nacto: 08/12/1965
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0510298
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 3481 4662

N° Epicrisis
298870

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 26/02/2022 20:50

Días Estadía: 12

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 10/03/2022 15:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Aumento de volumen de rostro

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Gloria Aguilera Ubilla
Edad: 56 años
Rut: 13.977.055-2

Antecedentes Médicos: Asma, Obesidad.
Antecedentes Quirúrgicos: No
Inmunizaciones: Vacuna COVID 3 dosis

Paciente con antecedentes descritos. Consultó el 26/02 en SU HSR, por cuadro iniciado hace 3 semanas de secreción ocular. 2 semanas previo al ingreso presentó aumento de volumen en rostro y luego en extremidades, posteriormente eritema, lesiones descamativas dolorosas y pruriginosas, además disminución de fuerza EESS.

Al interrogatorio, afebril, sin diarrea, sin vómitos, sin tos, sin inicio de fármacos ni exposición a alérgenos reciente.

Tomó prednisona 30mg por 7 días, hasta 3 días previo al ingreso.

Al ingreso taquicárdica, hipertensa, se detectan lesiones en piel de rostro, tronco superior y EESS, lesiones purpúricas, Nikolsky negativo, sin compromiso de mucosas.

Se sospechó Sd VCS vs RAM, se inició antihistamínicos y volemisación.

Se realizó AngioTAC tórax 26/02: Examen sin trombosis de vena cava superior. Tenue foco de condensación con densidad en vidrio esmerilado en el LSI de probable carácter inflamatorio infeccioso. Colelitiasis. Nefrolitiasis puntiforme bilateral.

El 28/02 en REG taquicárdica, hipotensa y mal perfundida, cianótica a distal polipneica, refiere dolor abdominal, signos esbozados de irritación peritoneal

Con mal acceso vascular, se instaló CVC yugular derecho ecoguiado. Ecoscopia con contractibilidad miocárdica hiperdinámica, sin derrame pericárdico, relación VD/VI conservada. VCI de difícil visualización con colapso parcial, edema en pared abdominal. Lung sliding bilateral, sin signos de patología intersticial, sin líquido libre abdominal, aorta abdominal dentro de límites normales, venas femorales compresibles a dos puntos.

Inicia requerimientos de DVA en ascenso

Se realiza AngioTAC Abdomen y Pelvis 28/02: Signos de un pequeño pseudoaneurisma en la arteria femoral común derecha, asociado a hematoma extraperitoneal en la pelvis. Disminución de calibre de ramas viscerales abdominales, probablemente en contexto de shock distributivo conocido. No se observan signos de isquemia transmural de asas intestinales. Signos de nefropatía aguda. Colelitiasis. Esteatosis hepática.

Evolución tórpida, polipneica, desatura y presenta compromiso de conciencia, a las 16:00 se procede a IOT por SIR, lograda en

Fecha Epicrisis : 10/03/2022 15:49

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 10-03-2022 15:49:46

Página 2 de 3

segundo intento con conductor. Con 13000 plaquetas se solicitó transfusión 4U Plaquetas
PCR en ascenso, PCR COVID negativo, se inició empíricamente Ceftriaxona
Requerimiento de DVA en ascenso, hasta NAD hasta 0.5, cursa acidosis metabólica severa, se administró Bicarbonato.
Evaluada por Dermatología, al examen Rash Heliotropo, pápulas Gottron, placa eritematoviolácea con descamación fina cara
externa de ambos muslos (signo del pistolero), zona del escote y cara externa de brazos, impresiona Dermatomiositis, sugieren
manejo con Corticoides sistémicos y tópicos.
Se decide traslado a UCI para continuar manejo
Al ingreso VMI AC/V FIO2 70%, NAD 0.8 Adrenalina 0.3

EVOLUCIÓN EN UCI

HEMODINÁMICO: Ingres a Shock séptico con gran requerimiento de DVA, con volemicación enérgica se logra reducción de
NA y suspensión de adrenalina. Taquicárdica persistente, sin arritmias. VEC normalizado.

Perfusión clínica adecuada, láctico aclarado. Anúrica.

Se deja sin tromboprolifaxis. Caída gradual de Hb, hoy en 10, en contexto de reanimación enérgica y sangrado por
pseudoaneurisma femoral derecha

Sospecha de IAM tipo 2, en vigilancia. Se solicitó Ecocardiograma.

Evoluciona con nuevo shock séptico el 09/03, con requerimientos de NA hasta 0.9 y Adrenalina hasta 0.1 asociado a láctico en
130. Se interpreta como nuevo shock séptico.

VENTILATORIO: Intubada por SDRA. Con sedación profunda y BNM.

TAC Tx del 26/01 Tenue foco de condensación con densidad en vidrio esmerilado en el LSI de probable carácter inflamatorio
infeccioso.

Conectada a VMI, AC volumen, PEEP 10, PP 19, Compliance st 23. PaFi 125.

No requirió pronó. Con componente de sobrecarga de volumen que responde a Bh negativo en diálisis.

Evoluciona con derrame pleural derecho.

INFECCIOSO: Se interpretó como shock séptico con componente de hipovolemia por sangrado en región femoral por
aneurisma, resuelto quirúrgicamente el 01/02.

Foco impresionó respiratorio. Dentro de estudio todo negativo. Se hemocultiva nuevamente y se rescata Candidemia, se inicia
Anidulafungina por gravedad. Completa 7 días de Imipenem y vancomicina.

Evoluciona con nuevo shock séptico, se reinicia Vancomicina asociado a Meropenem, se mantiene Anidulafungina.

HEPÁTICO: Cursando con hepatitis isquémica en contexto de FMO. Se inició Vit K completando 3 dosis. Evoluciona con nuevo
deterioro de pruebas hepáticas asociado a hipoglicemia, se interpretó como falla hepática.

REUMATOLÓGICO: Con sospecha de dermatomiositis (lesiones heliotropo, chal, CK elevadas).

Evaluada por especialidad, poco interpretable en contexto de shock.

Se mantuvo dosis de hidrocortisona, estaba con plan de estudio en diferido (panel de miositis).

Se realizó TAC TAP en búsqueda de proceso oncológico, negativo.

Pendiente mamografía, EDA, Colonoscopia, y evaluación por Ginecología.

RENAL: Cursando con falla renal aguda multifactorial (Shock, rabdomiolisis). Anúrica, acidótica y con hiperkalemia.

Evoluciona con mayor deterioro, se instala CHD y se iniciará diálisis.

Dentro de estudio C3 bajo, C4 normal inferior.

Por hipocalcemia se aporta Ca Ev.

NUTRICIONAL: Se mantuvo en régimen cero por shock. Sin RG.

En contexto de nuevo shock séptico presentó alza importante de DVA, sin respuesta a volemicación, administración de
bicarbonato de sodio e inicio de ATB.

1.FMO (hemodinámica, ventilatoria, renal, hepática, coagulación)

2.Shock séptico + hipovolémico en estudio

Neumonía LSD + aneurisma de arteria femoral derecha

3.Insuficiencia Respiratoria Aguda

SDRA

4.Falla renal aguda KDIGO III

Obs Rabdomiolisis

5.Obs IAM tipo 2 vs Miocarditis

6.Falla Hepática aguda

a.Hepatitis isquémica

7.Dermatomiositis en tratamiento

8.Antecedentes: Asma

Fecha Epicrisis : 10/03/2022 15:49

Página 2 de 3

Diagnóstico de Egreso

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA DE ORIGEN INFECCIOSO, CON FALLA ORGÁNICA -

Condición de Egreso

Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fallece el 10/03/22 a las 15:32.

Plan Post Alta

Se avisa a familiares quienes acompañan a paciente.

Se realiza Certificado de defunción.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

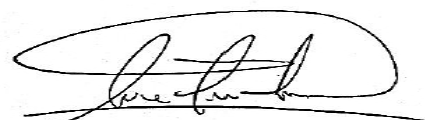
Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Mario Alex Contreras Torrez

Médico Tratante (Staff)